



ORIGINAL

Relación entre la sensibilidad moral y la cultura de seguridad del paciente de los enfermeros. Estudio descriptivo y correlacional

Melike Durmaz^{a,*} y Saide Faydali^b

^a Seljuk University, Faculty of Nursing, Surgical Nursing Department, Konya, Turkey

^b Necmettin Erbakan University, Faculty of Nursing, Surgical Nursing Department, Konya, Turkey

Recibido el 25 de julio de 2024; aceptado el 17 de marzo de 2025

Disponible en Internet el 12 de junio de 2025



PALABRAS CLAVE

Ética;
Enfermería;
Moral;
Seguridad del
paciente

Resumen

Objetivo: Este estudio se llevó a cabo para examinar la relación entre la sensibilidad moral de las enfermeras y la cultura de seguridad del paciente.

Método: Este estudio se diseñó utilizando un diseño transversal. La recopilación de datos implicó el uso de un cuestionario, el «Cuestionario de sensibilidad moral (MSQ)» y la «Escala de cultura de seguridad del paciente (PSCS)». Los datos se recopilaron de 254 enfermeros que aceptaron participar en la investigación utilizando un método de encuesta en línea entre el 1 y el 31 de enero de 2023.

Resultados: Se observó que las puntuaciones altas en las subdimensiones de autonomía y enfoque holístico de la escala de sensibilidad moral contribuían a aumentar las puntuaciones de la cultura de seguridad del paciente. Los niveles de sensibilidad moral y de cultura de la seguridad del paciente fueron elevados entre las enfermeras o enfermeros. Sin embargo, solo se encontró una relación negativa y débilmente significativa entre la subescala de autonomía de la escala de sensibilidad moral y la subescala de gestión y liderazgo de la escala de cultura de seguridad del paciente.

Conclusiones: En consecuencia, se recomienda llevar a cabo iniciativas de refuerzo separadas para las enfermeras en términos de sensibilidad moral y cultura de seguridad del paciente. Para explorar más a fondo la relación entre la sensibilidad moral de las enfermeras y la cultura de seguridad del paciente, se sugieren futuros estudios en los que participen enfermeras de diversos orígenes culturales y varios entornos sanitarios, utilizando métodos de investigación tanto cualitativos como cuantitativos.

© 2025 Publicado por Elsevier España, S.L.U.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: melikebiryoldurmaz@gmail.com (M. Durmaz).

<https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2025.502242>

1130-8621/© 2025 Publicado por Elsevier España, S.L.U.

KEYWORDS

Ethics;
Nursing;
Morals;
Patient safety

The relationship between nurses' moral sensitivity and patient safety cultures; descriptive and correlational study

Abstract

Objective: This study was conducted to examine the relationship between nurses' moral sensitivity and the culture of patient safety.

Methodology: This study was designed using a cross-sectional design. The data collection was carried out using a "Questionnaire", the "Moral Sensitivity Questionnaire (MSQ)", and the "Patient Safety Culture Scale (PSCS)". The data was obtained from 254 nurses who agreed to participate in the research through an online survey method conducted between January 01-31, 2023.

Results: High scores on the autonomy and holistic approach sub-dimensions of the moral sensitivity scale were found to contribute to an increase in patient safety culture scores. High levels of both moral sensitivity and patient safety culture were reported among nurses. However, only a negative and weak significant relationship was found between the autonomy subscale of the moral sensitivity scale and the management and leadership subscale of the patient safety culture scale.

Conclusions: Accordingly, it is recommended that separate strengthening initiatives be conducted for nurses in terms of moral sensitivity and patient safety culture. To further explore the relationship between nurses' moral sensitivity and patient safety culture, future studies involving nurses from diverse cultural backgrounds and various healthcare settings, utilizing both qualitative and quantitative research methods, it is suggested.

© 2025 Published by Elsevier España, S.L.U.

¿Qué se conoce?

El estudio ha reflejado que los niveles de sensibilidad moral y de cultura sobre la seguridad del paciente de los enfermeros son altos. Sin embargo, no existen publicaciones científicas que investiguen la relación entre la sensibilidad moral y la cultura de seguridad del paciente de los enfermeros.

¿Qué aporta?

El estudio revela que la relación entre los 2 conceptos es débil. Muestra que ambos conceptos son importantes en sí mismos, pero que el que uno de ellos sea fuerte no incrementa automáticamente el otro. Por tanto, se recomiendan prácticas separadas para mejorar tanto la sensibilidad moral como la cultura de seguridad del paciente.

comportamientos y prácticas de manera adecuada^{1,3-5}. La sensibilidad moral se define como la «concienciación por parte de los enfermeros de los problemas éticos que se encuentran durante su desempeño profesional y esfuerzos para realizar lo más adecuado en dicha situación, adhiriéndose a sus valores éticos profesionales»^{3,6}. Se piensa que los enfermeros desarrollarán la capacidad de reconocer y diferenciar lo que es correcto o beneficioso en una situación determinada, aportándose sensibilidad moral y cuidados desinteresados, sensibles y de alta calidad a los individuos¹. Se destaca que los efectos positivos sobre el desarrollo profesional y la calidad de la atención vienen determinados por los altos niveles de sensibilidad moral entre los enfermeros⁵⁻⁷.

Los enfermeros realizan funciones multifacéticas y diversas en cada etapa del tratamiento y el cuidado al paciente. Ellos aplican el tratamiento prescrito, pudiendo surgir incidentes tales como lesiones, caídas, errores de medicación, lesiones con instrumentos cortantes, úlceras por presión, y demás contingencias durante este proceso. Por tanto, los enfermeros juegan un papel importante para garantizar la seguridad del paciente⁸. Se ha pensado que los enfermeros prestarían un cuidado más meticuloso y esmerado a medida que se acrecienta la cultura de la seguridad del paciente, y a pesar de cualquier adversidad. En la literatura, se han realizado estudios separados en enfermeros para determinar los niveles de sensibilidad moral y sus factores de influencia^{1,4,5}, así como la cultura de seguridad del paciente y sus factores de influencia⁸⁻¹¹. Los problemas éticos que encuentran los enfermeros con mayor frecuencia en el proceso de atención al paciente implican la toma de decisión médica, el trasplante de órganos por muerte cere-

Introducción

El personal de enfermería puede encontrarse problemas y/o dilemas éticos durante el tratamiento y cuidado de los pacientes^{1,2}. Se prevé que los enfermeros desplieguen una sensibilidad moral mejorada cuando se enfrentan a dilemas éticos, lográndose un incremento de la concienciación, tomándose las decisiones correctas y desarrollándose

bral, el consentimiento informado, la toma de decisiones de reanimación y la iniciación-mantenimiento-terminación del soporte vital^{1,5}. Se destaca que dichos problemas están causados por situaciones relacionadas con el sistema sanitario tales como la utilización justa de los recursos la insuficiencia de materiales y personal, la ambigüedad de los roles y responsabilidades y el escalado de los costes^{1,2}. Cuando se encuentran cuestiones éticas, pueden adoptarse diferentes perspectivas y enfoques por parte de cada enfermero para solventar un problema ético. El nivel de sensibilidad ética del enfermero está considerado un factor esencial que influye en esto. Se argumenta que tener un alto nivel de sensibilidad ética es extremadamente importante para identificar problemas éticos y determinar enfoques adecuados para abordar estos¹². Un análisis conceptual de la sensibilidad ética ha sido asociado a los conceptos de "sufrimiento y vulnerabilidad del cliente, y a través de las relaciones caracterizadas por la receptividad, responsabilidad y animación por parte de los profesionales". Se dice que los resultados derivados del desarrollo de la sensibilidad ética incluyen elementos tales como la toma de decisiones preservadora de la integridad, la comodidad y el bienestar, el aprendizaje y la trascendencia profesional, alineados con valores u objetivos específicos¹³.

La tasa de incidencia de situaciones que amenazan la seguridad del paciente durante la prestación de servicios sanitarios es un indicador importante de la calidad de una institución⁸⁻¹⁰. Los factores que amenazan la seguridad del paciente y conducen a errores en el proceso de tratamiento y cuidado en la profesión enfermera se definen en forma de ratios enfermero-paciente insuficientes, elevada carga de trabajo, jornada laboral prolongada, entornos laborales estresantes, cuidado de los pacientes inconscientes o terminales, presencia de dispositivos médicos complejos, insuficiencia de material y horas de trabajo irregulares. En este escenario, pueden surgir brechas potenciales de seguridad del paciente^{5,11}. Se ha establecido que la administración de las instituciones posee responsabilidades significativas para fomentar la cultura de seguridad del paciente entre los profesionales sanitarios. Se afirma que los métodos para lograr esto incluyen mejorar la calidad, la educación, el reporte y documentación de errores, la facilitación de la comunicación paciente-médico-enfermero, y el incremento de las cifras del personal^{14,15}. Garantizar la seguridad del paciente es una responsabilidad ética de los profesionales sanitarios. Se prevé la priorización de la seguridad y bienestar de los pacientes durante la prestación de los servicios sanitarios. Los enfermeros juegan un papel activo en esta materia, para mejorar y mantener la seguridad del paciente.

No se ha encontrado ningún estudio que examine específicamente la relación entre la sensibilidad moral y la cultura de seguridad del paciente. Este estudio ha sido diseñado suponiendo que garantizar la seguridad del paciente será prioritario para los enfermeros con alta sensibilidad moral, originando unos mayores niveles de cultura sobre seguridad del paciente. En este contexto, en este estudio se ha investigado la relación entre la sensibilidad moral y la cultura de seguridad del paciente por parte de los enfermeros, como contribución a la literatura limitada sobre esta cuestión.

Métodos

Diseño

El estudio tuvo un diseño transversal.

Cuestiones del estudio

1. ¿Cuál es la relación entre la sensibilidad ética y la cultura de seguridad del paciente de los enfermeros?
2. ¿Afectan las características de los enfermeros a su sensibilidad ética?
3. ¿Afectan las características de los enfermeros a los niveles de cultura de seguridad del paciente?

Población y ámbito del estudio

Los datos de la investigación fueron obtenidos de los enfermeros (N = 731) trabajadores en un hospital público urbano, con una capacidad de camas total de 963 sujetos en la provincia de Konya, Turquía. Se calculó que, debido a la falta de estudios que examinaran la relación entre la sensibilidad ética y la seguridad del paciente, con valores de probabilidad (p, q) establecidos en 0,5 y una potencia del 95%, el tamaño muestral requerido, sobre la base de la población conocida, debería ser de 254 sujetos¹⁶. En el análisis de potencia calculado *post hoc*, esta se estableció en un 99%. Tras ser informados sobre el estudio, se incluyeron enfermeros voluntarios. Se excluyeron los enfermeros que estaban de baja, o que trabajaban en una institución externa durante el periodo de estudio.

Variables

Variables dependientes: Se evaluaron las puntuaciones sobre la cultura de seguridad del paciente y la sensibilidad moral de los enfermeros.

Variables independientes: Se incluyeron las características personales (edad, sexo, educación, estado civil) y profesionales (puesto, unidad, experiencia, ética y formación sobre seguridad del paciente) de los enfermeros.

Recopilación de los datos

Los datos fueron recopilados electrónicamente utilizando un método de encuesta *online* entre el 1 y el 31 de enero de 2023. Se registró un tiempo de entre 10 y 15 min para completar los formularios. El enlace de la encuesta fue distribuido a los enfermeros participantes mediante correo electrónico y redes sociales (Facebook®, Instagram®, WhatsApp®). La realización de la encuesta se restringió a un único formulario por participante. Se animó a los enfermeros participantes a compartir el enlace de la encuesta en sus plataformas de redes sociales. Debido a la recopilación electrónica de los datos de la investigación, no existió interacción personal ni verbal directa entre los investigadores y los enfermeros. Las herramientas de recopilación de los datos incluyeron un «cuestionario» que englobaba las características personales y profesionales de los enfermeros, el

«Cuestionario de sensibilidad moral (MSQ)», y la «Escala de cultura de seguridad del paciente (PSCS)».

MSQ, desarrollado por Kim Lützen en 1994 para medir la sensibilidad ética de los enfermeros en los procesos de toma de decisiones, fue adaptado a la cultura turca por Hale Tosun en 2005⁷. Dicho cuestionario incluye 30 ítems en una escala Likert de 7 puntos, fue estructurado en 6 subescalas: «autonomía», «aportación de beneficio», «enfoque holístico», «conflicto», «aplicación» y «orientación». La puntuación total obtenible de MSQ fluctúa de 30 a 210, indicando las escalas más bajas una mayor sensibilidad ética. En el estudio de adaptación, se reportó un valor alfa de Cronbach de 0,84⁷, mientras que, en este estudio, se calculó en 0,94.

PSCS, desarrollada por Turkmen et al. (2011), fue utilizada para evaluar la cultura de seguridad del paciente. Esta escala incluyó 51 ítems en una escala de Likert de 4 puntos, e incluyó cinco subescalas: «gestión y liderazgo», «comportamiento del empleado», «reporte de episodios y errores inesperados», «formación de los empleados», y «entorno de cuidados». La escala y sus subescalas se puntuaron de 1 a 4, dividiendo la puntuación total entre el número de ítems. Las puntuaciones más bajas (cerca de 1) indicaron una cultura de seguridad del paciente negativa, mientras que las más altas (cerca de 4) indicaron una cultura de seguridad del paciente positiva. El valor alfa de Cronbach para PSCS se estableció en 0,97¹⁴ en el estudio original, siendo de 0,98 en este estudio.

Análisis de los datos

Los datos descriptivos del estudio se presentaron mediante frecuencias, porcentajes, medias y desviaciones estándar. Para evaluar la distribución normal de los datos, se aplicaron la escala Likert y las pruebas de asimetría/Curtosis, confirmando la distribución normal los resultados comprendidos en el rango de $-1,5$ a $+1,5$ ¹⁷. Para revelar las diferencias entre variables, se realizaron pruebas t para muestras independientes y ANOVA unidireccional. Se realizó el análisis de correlación de Pearson para determinar la relación entre las escalas. Los niveles de correlación se clasificaron como sigue: de 0 a 0,10 insignificante, de 0,10 a 0,39 débil, de 0,40 a 0,69 moderada, de 0,70 a 0,89 fuerte, y 0,90 a 1 muy fuerte¹⁸.

Aspectos éticos

La investigación fue realizada siguiendo los principios de la Declaración de Helsinki. Se utilizó la lista de verificación STROBE (*Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology*) durante la preparación del artículo. Se presentaron formularios de consentimiento informado a los participantes en formato online, y solo aquellos que aprobaron los formularios procedieron a completar la encuesta. Se obtuvo autorización de sus desarrolladores para utilizar MSQ y PSCS. La autorización institucional fue concedida por la Facultad de Medicina del Hospital Selçuk (Fecha: 27.12.2022, Número: E-30292447-100-429038). Se obtuvo aprobación ética del Comité de ética de investigación clínica no intervencionista de la Facultad de Enfermería de la Universidad Selçuk (Fecha: 30.12.2022, Número: 2022/64).

Resultados

Características de los enfermeros

La muestra final incluyó 254 enfermeros trabajadores en diversas clínicas, con una edad media de $32,35 \pm 7,36$ años. Se excluyó a 2 participantes con datos incompletos, sustituyéndose sus respuestas por 2 nuevos participantes, para lograr el tamaño muestral requerido. La mayoría de los participantes fueron mujeres (70,5%, $n=179$) y casados (61%, $n=155$). La mitad de los participantes eran licenciados (50,4%, $n=128$). Los enfermeros clínicos (24,4%, $n=62$) y los enfermeros de cuidados intensivos (20,5%, $n=52$) representaron la mayoría. Un total del 50% de los participantes reportaron de uno a 10 años de experiencia profesional. Se advirtió que el 88,2% ($n=224$) de los participantes había recibido formación en ética profesional y seguridad del paciente tras la graduación (tabla 1).

Sensibilidad moral y cultura de seguridad del paciente de los enfermeros

La puntuación MSQ media de los enfermeros fue de $86,87 \pm 35,18$, y se determinó que los niveles de sensibilidad moral eran altos en todas las subescalas. La puntuación PSCS media y sus subescalas superaron un valor de 3, indicativo de un alto nivel de cultura de seguridad del paciente entre los enfermeros (tabla 2).

Relación entre la sensibilidad moral y la seguridad del paciente de los enfermeros

Al examinar la relación entre los niveles de sensibilidad moral y cultura de seguridad del paciente de los enfermeros, se identificó una correlación negativa y débil, aunque significativa entre la subescala de autonomía de MSQ y la subescala de gestión y liderazgo de PSCS ($p < 0,05$). En general, la relación entre las puntuaciones de estas escalas fue desdeñable (tabla 3).

Niveles de sensibilidad moral de acuerdo con las características de los enfermeros

No se observaron diferencias significativas en las puntuaciones MSQ totales sobre la base de las características de los enfermeros. En las subescalas, se encontró que las mujeres tenían puntuaciones más altas en las subescalas de «enfoque holístico» y «orientación», mientras que aquellos con menores niveles de educación tuvieron puntuaciones más altas en las subescalas de «aportación de beneficio». Los enfermeros con menos de un año de experiencia profesional tuvieron puntuaciones más altas en la subescala de «conflicto», en comparación con aquellos con 11 años de experiencia o más ($p < 0,05$) (tabla 4).

Tabla 1 Características de los enfermeros (n = 254)

Características	n	%
<i>Edad^a</i>		
20-32 años	140	55,1
33-53 años	114	44,9
<i>Sexo</i>		
Mujer	179	70,5
Varón	75	29,5
<i>Estado civil</i>		
Casado	155	61
Soltero	99	39
<i>Nivel educativo</i>		
Formación profesional en salud	53	20,9
Título de asociado	48	18,9
Licenciatura	128	50,4
Título de máster	25	9,8
<i>Área laboral</i>		
Enfermero clínico	62	24,4
Enfermero de cuidados intensivos	52	20,5
Enfermero de urgencias	44	17,3
Enfermero de policlínica	35	13,8
Enfermero de quirófano	27	10,6
Enfermero obstétrico/pediátrico	17	6,7
Gestor o educador enfermero	17	6,7
<i>Experiencia profesional</i>		
Menos de un año	15	5,9
1-10 años	127	50
11 años o más	112	44,1
<i>Ha recibido formación sobre ética profesional tras la graduación</i>		
Sí	224	88,2
No	30	11,8
<i>Ha recibido formación sobre seguridad del paciente tras la graduación</i>		
Sí	224	88,2
No	30	11,8

^a La agrupación anterior se realizó teniendo en cuenta el valor medio ($\bar{x}$: 32,35 $\pm$ 7,36 min: 20, máx: 53).

Tabla 2 Puntuaciones de sensibilidad moral y cultura de seguridad del paciente de los enfermeros (n = 254)

Escala y subescalas	$\bar{x} \pm DE$	Min	Máx
MSQ total	86,87 $\pm$ 35,18	30	208
Autonomía	18,98 $\pm$ 9,39	7	49
Aportación de beneficio	12,91 $\pm$ 5,39	4	28
Enfoque holístico	12,87 $\pm$ 6,76	5	35
Conflicto	11,95 $\pm$ 4,74	3	21
Aplicación	11,59 $\pm$ 5,46	4	28
Orientación	9,67 $\pm$ 5,95	4	28
PSCS total	3,09 $\pm$ 0,67	1	4
Gestión y liderazgo	3,08 $\pm$ 0,66	1	4
Formación de los empleados	3,10 $\pm$ 0,80	1	4
Reporte de episodios y errores inesperados	3,02 $\pm$ 0,78	1	4
Entorno de cuidados	3,15 $\pm$ 0,70	1	4
Comportamiento del empleado	3,10 $\pm$ 0,74	1	4

DE: desviación estándar; MSQ: cuestionario de sensibilidad moral; PSCS: escala de cultura de seguridad del paciente.

Tabla 3 Relación entre la sensibilidad moral y la cultura de seguridad del paciente de los enfermeros (n = 254)

	Autonomía	Aportación de beneficio	Enfoque holístico	Conflicto	Aplicación	Orientación	MSQ total
<i>Gestión y liderazgo</i>							
r	-0,134	-0,031	-0,094	-0,030	-0,073	-0,116	-0,099
p	0,033	0,620	0,133	0,630	0,247	0,065	0,114
<i>Formación de los empleados</i>							
r	-0,115	-0,046	-0,082	-0,018	-0,088	-0,085	-0,093
p	0,068	0,464	0,195	0,780	0,161	0,175	0,139
<i>Reporte de episodios y errores inesperados</i>							
r	-0,070	0,005	-0,032	-0,012	-0,034	-0,026	-0,037
p	0,268	0,932	0,617	0,851	0,591	0,677	0,552
<i>Entorno de cuidados</i>							
r	-0,121	0,003	-0,107	0,004	-0,076	-0,104	-0,037
p	0,054	0,957	0,087	0,955	0,230	0,100	0,552
<i>Comportamiento del empleado</i>							
r	-0,090	0,010	-0,068	0,002	-0,043	-0,071	-0,057
p	0,153	0,876	0,279	0,978	0,493	0,257	0,368
<i>PSCS total</i>							
r	-0,119	-0,014	-0,087	-0,013	-0,068	-0,094	-0,084
p	0,059	0,827	0,168	0,834	0,279	0,134	0,182

MSQ: cuestionario de sensibilidad moral; PSCS: escala de cultura de seguridad del paciente.

Niveles de cultura de seguridad del paciente de acuerdo con las características de los enfermeros

En la puntuación total de PSCS, se encontró que los solteros tenían niveles de cultura de seguridad del paciente considerablemente más altos que los sujetos casados, los que trabajaban en el quirófano tenían niveles más altos que los enfermeros clínicos y los de cuidados intensivos, y aquellos con menos de un año de experiencia tenían niveles más altos, en comparación con aquellos con mayor experiencia ($p < 0,05$). No se observaron diferencias significativas en función de la edad, educación o formación recibidas en cuanto a ética profesional y seguridad del paciente (tabla 5).

Discusión

En este estudio, aunque los enfermeros tuvieron niveles altos de sensibilidad moral y cultura de seguridad del paciente, al examinar las relaciones se encontró que existía una correlación insignificante y débil. Cabe destacar que solo se observó una correlación significativa en la dimensión de autonomía de MSQ y en las de gestión y liderazgo de PSCS, interpretándose que a medida que disminuye la puntuación MSQ se incrementa la sensibilidad. Por tanto, el hecho de que la relación sea generalmente negativa puede deberse al modo de puntuarse MSQ. No se ha encontrado un estudio similar, pero se ha encontrado una relación negativa, débil y significativa entre los comportamientos de cuidados y las sensibilidades morales de los enfermeros¹⁹. Aunque la relación es débil, se piensa que es importante para mejorarla clínicamente para el beneficio del paciente. Sin embargo, dichos resultados sugieren la necesidad de desarrollar estrategias independientes para incrementar la sensibilidad moral y/o la cultura de seguridad del paciente en los enfermeros.

La investigación determinó que los niveles de sensibilidad moral de los enfermeros eran altos. Aunque existen estudios similares en los que se encontró que la sensibilidad moral era alta en los enfermeros^{20,21}, algunos estudios encontraron un nivel moderado^{5,12,22,23}. No se encontró diferencia significativa en las puntuaciones totales de MSQ, la subdimensión de autonomía y la subdimensión de práctica de acuerdo con las características de los enfermeros. Se determinó que aquellos con un nivel de educación bajo tenían mayor sensibilidad en la subescala de 'aportación de beneficio', las mujeres en la subescala de 'enfoque holístico', aquellos con bajo nivel educativo y menos de un año de experiencia en la subescala de 'conflicto', mostrando las mujeres en la subescala de 'orientación' un mayor nivel de sensibilidad que el resto. En un metaanálisis, se estableció que el sexo tenía un impacto en la sensibilidad ética²⁴; sin embargo, otros estudios realizados con enfermeros de cuidados intensivos encontraron que el sexo no afectó a la sensibilidad ética²⁵. Aunque existen estudios en la literatura que destacan que los niveles de sensibilidad aumentan a medida que se incrementa el nivel educativo^{19,21}, existen también estudios que muestran que no existe relación significativa entre el nivel educativo y la sensibilidad moral^{23,26}. En una investigación realizada con enfermeros quirúrgicos y de cuidados intensivos internistas, se estableció que la experiencia profesional no afectó al nivel de sensibilidad moral²¹, y en un estudio realizado con enfermeros pediátricos, se encontró que la sensibilidad de los enfermeros con mayor experiencia profesional fue superior que en aquellos con menor experiencia²⁷. Parece que se han obtenido diferentes resultados en términos del efecto de las características enfermeras sobre el nivel de sensibilidad moral, siendo necesarios más análisis detallados y profundos para determinar si los resultados obtenidos son fortuitos o no. La falta de diferencias significativas en cuanto a sensibilidad, sobre la base de las características de los participantes, sugiere que la estructura de la sensibilidad moral es universal, moldeada por las influencias unificado-

Tabla 4 NivelEs de sensibilidad de acuerdo con las características de los enfermeros (n = 254)

Características	n	MSQ $\bar{x} \pm DE$	Autonomía $\bar{x} \pm DE$	Aportación de beneficio $\bar{x} \pm DE$	Enfoque holístico $\bar{x} \pm DE$	Conflicto $\bar{x} \pm DE$	Aplicación $\bar{x} \pm DE$	Orientación $\bar{x} \pm DE$
<i>Edad</i>								
20-32 años	140	83,43 $\pm$ 34,14	18,24 $\pm$ 8,96	12,50 $\pm$ 5,48	12,44 $\pm$ 6,44	11,49 $\pm$ 4,97	11,16 $\pm$ 5,21	9,16 $\pm$ 5,79
33-53 años	114	91,09 $\pm$ 36,11	19,89 $\pm$ 9,84	13,42 $\pm$ 5,25	13,39 $\pm$ 7,13	12,52 $\pm$ 4,39	12,11 $\pm$ 5,72	10,28 $\pm$ 6,12
t*; p		-1,733; 0,084	0,112; 0,911	-1,358; 0,176	-1,106; 0,270	-1,724; 0,086	-1,393; 0,165	-1,490; 0,137
<i>Sexo</i>								
Mujer	179	84,46 $\pm$ 31,55	18,46 $\pm$ 8,67	12,65 $\pm$ 4,83	12,26 $\pm$ 6,11	12,07 $\pm$ 4,59	11,29 $\pm$ 5,15	8,96 $\pm$ 5,46
Varón	75	92,61 $\pm$ 42,65	20,20 $\pm$ 10,88	13,53 $\pm$ 6,52	14,32 $\pm$ 7,97	11,66 $\pm$ 5,10	12,29 $\pm$ 6,11	11,36 $\pm$ 6,74
t*; p		-1,495; 0,138	-1,229; 0,222	-1,054; 0,294	-2,008; 0,047	0,626; 0,532	-1,338; 0,182	-2,737; 0,007
<i>Estado civil</i>								
Casado	155	87,79 $\pm$ 34,81	19,03 $\pm$ 9,31	12,89 $\pm$ 5,29	13,14 $\pm$ 6,83	11,90 $\pm$ 4,73	11,56 $\pm$ 5,49	10,07 $\pm$ 5,99
Soltero	99	85,42 $\pm$ 35,88	18,89 $\pm$ 9,55	12,95 $\pm$ 5,56	12,44 $\pm$ 6,67	12,03 $\pm$ 4,77	11,64 $\pm$ 5,43	9,04 $\pm$ 5,87
t*; p		0,521; 0,603	0,119; 0,906	-0,085; 0,932	0,794; 0,428	-0,209; 0,835	-0,116; 0,908	1,339; 0,182
<i>Nivel educativo</i>								
Formación profesional en salud/título de asociado	101	84,48 $\pm$ 38,59	18,70 $\pm$ 10,24	12,04 $\pm$ 5,51	13,03 $\pm$ 7,35	11,12 $\pm$ 5,16	10,85 $\pm$ 5,74	10,03 $\pm$ 6,27
Título de licenciado y de máster	153	88,44 $\pm$ 32,77	19,16 $\pm$ 8,81	13,49 $\pm$ 5,24	12,76 $\pm$ 6,37	12,51 $\pm$ 4,37	12,07 $\pm$ 5,22	9,42 $\pm$ 5,75
t*; p		-0,880; 0,380	-0,377; 0,707	-2,115; 0,035	0,313; 0,755	-2,300; 0,022	-1,752; 0,081	0,792; 0,429

Tabla 4 (continuación)

Características	n	MSQ $\bar{x} \pm DE$	Autonomía $\bar{x} \pm DE$	Aportación de beneficio $\bar{x} \pm DE$	Enfoque holístico $\bar{x} \pm DE$	Conflicto $\bar{x} \pm DE$	Aplicación $\bar{x} \pm DE$	Orientación $\bar{x} \pm DE$
<i>Área de trabajo</i>								
Enfermero clínico	62	90,42 ± 28,22	19,84 ± 7,77	13,46 ± 4,83	13,46 ± 6,05	12,37 ± 4,33	12,40 ± 4,52	10,11 ± 5,40
Gestor o educador enfermero	17	94,24 ± 41,96	21,00 ± 10,96	14,06 ± 5,79	14,18 ± 8,12	12,18 ± 4,52	12,24 ± 6,24	10,53 ± 6,74
Enfermero de cuidados intensivos	52	91,02 ± 40,80	20,31 ± 11,20	13,98 ± 5,57	13,21 ± 7,72	12,18 ± 5,07	11,88 ± 5,83	10,58 ± 6,95
Enfermero de policlínica	35	80,03 ± 32,43	16,71 ± 9,08	12,00 ± 5,29	11,29 ± 6,18	12,43 ± 4,24	10,54 ± 5,71	8,11 ± 5,47
Enfermero de urgencias	44	87,27 ± 32,89	19,14 ± 8,49	12,82 ± 5,29	13,18 ± 5,90	11,50 ± 4,60	11,72 ± 5,25	10,00 ± 5,47
Enfermero de quirófano	27	80,07 ± 32,43	17,19 ± 10,12	11,44 ± 5,85	12,22 ± 7,77	10,93 ± 5,60	10,74 ± 6,40	8,85 ± 6,60
Enfermero obstétrico/pediátrico	17	77,65 ± 33,49	16,82 ± 8,51	10,94 ± 5,57	11,76 ± 6,64	11,35 ± 5,60	10,17 ± 5,12	8,00 ± 4,61
F**; p		0,933; 0,472	1,049; 0,394	1,479; 0,186	0,656; 0,685	0,482; 0,822	0,809; 0,563	1,047; 0,395
<i>Experiencia profesional</i>								
Menos de un año	15	76,80 ± 49,62	17,73 ± 11,81	12,00 ± 7,19	11,40 ± 9,08	8,93 ± 5,66	10,60 ± 6,95	9,07 ± 7,39
1-10 años	127	84,98 ± 32,93	18,36 ± 8,71	12,70 ± 5,33	12,54 ± 6,29	11,88 ± 4,92	11,54 ± 5,23	9,26 ± 5,51
11 años o más	112	90,35 ± 35,35	19,84 ± 9,78	13,28 ± 5,20	13,44 ± 6,94	12,44 ± 4,26	11,78 ± 5,53	10,21 ± 6,24
F**; p		1,348; 0,262	0,876; 0,418	0,568; 0,568	0,904; 0,406	3,727; 0,025 a-c	0,317; 0,729	0,830; 0,437
<i>Recibe formación sobre ética profesional tras la graduación</i>								
Sí	224	85,63 ± 34,11	18,67 ± 9,13	12,69 ± 5,24	12,56 ± 6,52	11,91 ± 4,78	11,44 ± 5,40	9,49 ± 5,81
No	30	96,07 ± 41,80	21,23 ± 10,99	14,57 ± 6,25	15,13 ± 8,11	12,28 ± 4,45	12,67 ± 5,82	11,00 ± 6,90
t*; p		-1,529; 0,127	-1,405; 0,161	-1,798; 0,073	-1,966; 0,050	-0,390; 0,697	-1,155; 0,249	-1,309; 0,192
<i>Recibe formación sobre la seguridad del paciente tras la graduación</i>								
Sí	224	86,63 ± 35,48	18,84 ± 9,49	12,81 ± 5,30	12,74 ± 6,73	12,04 ± 4,84	11,57 ± 5,55	9,73 ± 5,95
No	30	88,67 ± 33,36	19,97 ± 8,65	13,70 ± 6,00	13,80 ± 7,03	11,24 ± 3,84	11,73 ± 4,75	9,20 ± 6,03
t*; p		0,298; 0,766	-0,615; 0,539	-0,851; 0,395	-0,805; 0,422	0,858; 0,392	-0,157; 0,876	0,455; 0,649

DE: desviación estándar; MSQ: cuestionario de sensibilidad moral.

* Prueba t para muestra independiente.

** ANOVA unidireccional, prueba posthoc de Scheffe,

Tabla 5 Niveles de cultura de seguridad del paciente de acuerdo con las características de los enfermeros (n = 254)

Características	N	PSCS	Gestión y liderazgo	Formación de empleados	Reporte de episodios y errores inesperados	Entorno de cuidados	Comportamiento del empleado
		$\bar{x} \pm DE$	$\bar{x} \pm DE$	$\bar{x} \pm DE$	$\bar{x} \pm DE$	$\bar{x} \pm DE$	$\bar{x} \pm DE$
<i>Edad</i>							
20-32 años	140	3,10 $\pm$ 0,69	3,08 $\pm$ 0,69	3,07 $\pm$ 0,82	3,05 $\pm$ 0,80	3,14 $\pm$ 0,72	3,12 $\pm$ 0,74
33-53 años	114	3,09 $\pm$ 0,64	3,08 $\pm$ 0,63	3,13 $\pm$ 0,77	2,99 $\pm$ 0,75	3,15 $\pm$ 0,68	3,08 $\pm$ 0,74
t*; p		0,111; 0,912	0,046; 0,963	−0,632; 0,528	0,570; 0,569	−0,083; 0,934	0,484; 0,629
<i>Sexo</i>							
Mujer	179	3,11 $\pm$ 0,65	3,07 $\pm$ 0,67	3,11 $\pm$ 0,78	3,07 $\pm$ 0,75	3,16 $\pm$ 0,67	3,12 $\pm$ 0,73
Varón	75	3,06 $\pm$ 0,69	3,09 $\pm$ 0,65	3,07 $\pm$ 0,83	2,92 $\pm$ 0,83	3,10 $\pm$ 0,77	3,06 $\pm$ 0,78
t*; p		0,442; 0,659	−0,243; 0,808	0,355; 0,723	1,358; 0,176	0,705; 0,481	0,634; 0,527
<i>Estado civil</i>							
Casado	155	3,02 $\pm$ 0,68	3,00 $\pm$ 0,69	3,03 $\pm$ 0,81	2,96 $\pm$ 0,78	3,08 $\pm$ 0,70	3,03 $\pm$ 0,76
Soltero	99	3,21 $\pm$ 0,63	3,20 $\pm$ 0,77	3,20 $\pm$ 0,77	3,12 $\pm$ 0,76	3,26 $\pm$ 0,68	3,22 $\pm$ 0,70
t*; p		−2,163; 0,031	−2,293; 0,023	−1,605; 0,110	−1,632; 0,104	−2,043; 0,040	−2,008; 0,046
<i>Nivel educativo</i>							
Formación profesional en salud/ título de asociado	101	3,17 $\pm$ 0,69	3,14 $\pm$ 0,68	3,21 $\pm$ 0,80	3,10 $\pm$ 0,76	3,20 $\pm$ 0,78	3,19 $\pm$ 0,77
Título de licenciado y de máster	153	3,04 $\pm$ 0,64	3,04 $\pm$ 0,65	3,03 $\pm$ 0,79	2,97 $\pm$ 0,79	3,11 $\pm$ 0,64	3,05 $\pm$ 0,72
t*; p		1,469; 0,143	1,280; 0,202	1,754; 0,081	1,285; 0,200	1,030; 0,304	1,437; 0,152

Tabla 5 (continuación)

Características	N	PSCS	Gestión y liderazgo	Formación de empleados	Reporte de episodios y errores inesperados	Entorno de cuidados	Comportamiento del empleado
		$\bar{x} \pm DE$	$\bar{x} \pm DE$	$\bar{x} \pm DE$	$\bar{x} \pm DE$	$\bar{x} \pm DE$	$\bar{x} \pm DE$
<i>Área de trabajo</i>							
Enfermero clínico	62	2,94 ± 0,62	2,92 ± 0,62	2,90 ± 0,77	2,77 ± 0,74	3,03 ± 0,66	3,01 ± 0,67
Gestor o educador enfermero	17	3,16 ± 0,61	3,14 ± 0,66	3,07 ± 0,72	3,28 ± 0,64	3,21 ± 0,61	3,17 ± 0,66
Enfermero de cuidados intensivos	52	2,94 ± 0,73	2,94 ± 0,72	2,90 ± 0,84	2,92 ± 0,82	3,05 ± 0,73	2,92 ± 0,83
Enfermero de policlínica	35	3,20 ± 0,57	3,22 ± 0,55	3,33 ± 0,69	3,05 ± 0,76	3,25 ± 0,66	3,16 ± 0,72
Enfermero de urgencias	44	3,04 ± 0,67	2,97 ± 0,70	3,08 ± 0,81	3,06 ± 0,79	2,96 ± 0,71	3,13 ± 0,71
Enfermero de quirófano	27	3,48 ± 0,64	3,52 ± 0,51	3,47 ± 0,79	3,44 ± 0,67	3,56 ± 0,71	3,42 ± 0,78
Enfermero obstétrico/pediátrico	17	3,32 ± 0,62	3,29 ± 0,60	3,42 ± 0,68	3,19 ± 0,76	3,43 ± 0,56	3,27 ± 0,71
F**; P		3,242; 0,004f-a,c	4,007; 0,001f-a,c,e	3,299; 0,004f-a,c	3,158; 0,005f-a	3,349; 0,003 f-e	1,799; 0,100
<i>Experiencia profesional</i>							
Menos de un año	15	3,53 ± 0,82	3,46 ± 0,83	3,57 ± 0,79	3,48 ± 0,93	3,62 ± 0,78	3,57 ± 0,87
1-10 años	127	3,05 ± 0,67	3,05 ± 0,66	3,03 ± 0,82	2,99 ± 0,79	3,09 ± 0,70	3,06 ± 0,74
11 años o más	112	3,08 ± 0,62	3,07 ± 0,63	3,11 ± 0,75	3,00 ± 0,72	3,14 ± 0,70	3,09 ± 0,71
F**; P		3,648; 0,027a-b,c	2,749; 0,066	3,210; 0,042a-b,c	2,814; 0,062	3,844; 0,023a-b,c	3,301; 0,038a-b,c
<i>Recibe formación sobre ética profesional tras la graduación</i>							
Sí	224	3,09 ± 0,66	3,08 ± 0,66	3,10 ± 0,81	3,00 ± 0,78	3,14 ± 0,70	3,10 ± 0,74
No	30	3,12 ± 0,69	3,09 ± 0,69	3,11 ± 0,72	3,16 ± 0,76	3,20 ± 0,70	3,13 ± 0,75
t*; p		-0,291; 0,771	-0,120; 0,905	-0,051; 0,960	-1,036; 0,301	-0,412; 0,679	-0,185; 0,853
<i>Recibe formación sobre la seguridad del paciente tras la graduación</i>							
Sí	224	3,10 ± 0,65	3,10 ± 0,65	3,11 ± 0,79	3,03 ± 0,76	3,16 ± 0,70	3,11 ± 0,71
No	30	2,99 ± 0,75	2,92 ± 0,73	2,99 ± 0,82	2,97 ± 0,89	3,05 ± 0,73	3,04 ± 0,89
t*; p		0,912; 0,363	1,386; 0,167	0,788; 0,432	0,365; 0,715	0,837; 0,404	0,401; 0,691

DE: desviación estándar; PSCS: escala de cultura de seguridad del paciente.

* Prueba t para muestra independiente.

** ANOVA unidireccional, prueba *post hoc* de Scheffe.

ras de la globalización, la educación, los medios y los valores societarios compartidos.

En cuanto a la cultura de seguridad del paciente, se encontraron niveles similares en esta investigación^{11,28}. En una revisión sistemática realizada en Turquía, se estableció que la cultura de seguridad del paciente de los enfermeros se situaba generalmente a nivel moderado²⁹. Aunque existen estudios que respaldan que las percepciones sobre la cultura de seguridad del paciente individual de los enfermeros son altas^{30,31}, existen estudios en los que no existen diferencias significativas^{22,32,33}. Un estudio estableció que el departamento/clínica en el que se trabajaba no tenía efecto en la cultura de seguridad del paciente²⁸. En la literatura se encontró que los enfermeros de quirófano y cuidados intensivos tenían mayores puntuaciones sobre cultura de seguridad del paciente que los enfermeros que trabajaban en clínica internista³⁴, y otro estudio encontró que los enfermeros que trabajaban en unidades internistas tenían mayores puntuaciones de cultura de seguridad del paciente que los enfermeros que trabajaban en unidades quirúrgicas³². Se sugiere que el alto nivel de cultura de seguridad del paciente en los enfermeros de quirófano puede deberse a las listas de verificación sobre seguridad de cirugía y procedimientos quirúrgicos de la OMS, pudiendo estar también relacionado con la evaluación intensiva de la seguridad del paciente, debido a la naturaleza del campo. De manera similar a este estudio, existe un estudio que muestra que las puntuaciones de cultura de seguridad del paciente de los enfermeros que llevan trabajando menos de un año son más altas que en otros grupos³⁵, aunque se ha demostrado que la experiencia no tiene efecto alguno^{9,10}. Hay estudios que muestran que aquellos con más experiencia tienen una percepción alta sobre seguridad del paciente^{28,32,34,36}. El hallazgo de que los datos demográficos de los participantes no influyen significativamente en los niveles de cultura de seguridad del paciente respalda la hipótesis de que los programas de formación institucional sobre esta cuestión son efectivos y se implementan sistemáticamente. También sugiere que la cultura de seguridad del paciente se ha convertido en un valor universal, y que el equipo de trabajo y la colaboración son fuertes, superando la motivación colectiva sobre seguridad del paciente a los factores individuales.

Fuimos de la opinión de que formar a los enfermeros sobre ética profesional y seguridad del paciente supondría marcar una diferencia en ambas cuestiones. Sin embargo, no existió diferencia en nuestros resultados entre aquellos que recibieron formación y aquellos que no. En un estudio se concluyó que mientras que no existió diferencia significativa en la sensibilidad moral de los enfermeros que realizaban un curso ético en educación básica, aquellos que recibieron formación con fundamento ético tras la graduación tuvieron mayores sensibilidades morales²⁵. En una revisión sistemática, resultó claro que el seminario sobre ética enfermera impartido durante la formación continua en las instituciones³⁷ o la realización de un curso sobre ética durante su formación profesional no tenía efecto sobre la sensibilidad moral en los enfermeros³⁰. Un estudio reportó que la sensibilidad moral de los enfermeros de quirófano que no recibieron formación ética fue mayor que la de los que sí recibieron dicha formación²³. Rizalar et al. (2016) reportaron que los enfermeros que recibieron formación ética

tenían mayores puntuaciones en la escala de cultura de seguridad del paciente⁸.

Cuando examinamos el efecto de la educación enfermera en los niveles de sensibilidad moral y cultura de seguridad del paciente nos hizo pensar que deberían examinarse las formaciones cualitativamente, que la educación que cubre el conocimiento teórico no es suficiente para la sensibilidad y aculturación, y que son necesarios técnicas y métodos diferentes. La combinación de Internet y lectura, las técnicas educativas interactivas tales como el autoestudio basado en Internet, la simulación, el aprendizaje grupal, el análisis de las cuestiones éticas o la interpretación de roles han revelado diferencias significativas en cuanto a ganancia de sensibilidad moral^{38,39}. Los valores personales afectan a la sensibilidad moral, estableciéndose que los enfermeros que adoptan valores sociales tienen mayores niveles éticos, mientras que los enfermeros con valores económicos básicos tienen un menor nivel de sensibilidad ética⁵. Aunque la cultura de seguridad del paciente es un concepto abstracto, se han producido soluciones concretas para regular esto, tales como la adopción de precauciones utilizando políticas, procedimientos y dispositivos de seguridad^{40,41}. La sensibilidad moral y la seguridad del paciente constituyen bloques de construcción importantes de la profesión enfermera. En línea con los datos obtenidos, puede examinarse con mayor profundidad y ofrecer una nueva perspectiva sobre educación enfermera y práctica clínica. El estudio tiene diversas limitaciones. La homogeneidad del grupo muestral (un único hospital y enfermeros) limita la generalizabilidad de los hallazgos. Otra limitación es que la naturaleza transversal de los datos no permite la evaluación de los cambios con el tiempo. Una limitación añadida del estudio reside en el hecho de que una proporción sustancial de los participantes ha realizado formación de posgrado sobre ética profesional y seguridad del paciente. Ello puede haber introducido un sesgo de selección, ya que los enfermeros con un interés preexistente en la cuestión de estudio pueden haber sido más propensos a participar. En consecuencia, este sesgo potencial puede haber comprometido la generalizabilidad del hallazgo del estudio. Los estudios futuros realizados con muestras de mayor tamaño en diversas instituciones sanitarias y en diferentes países podrían mejorar la generalizabilidad de los hallazgos. Además, para mejorar la homogeneidad de la población de la muestra, deben tenerse en cuenta los niveles de las titulaciones educativas de posgrado entre los enfermeros.

Conclusiones

Los resultados indicaron que los enfermeros exhibieron puntuaciones más altas en las escalas de sensibilidad moral y cultura de seguridad del paciente. Sin embargo, no se encontró correlación entre ambos constructos. Aunque este hallazgo sugiere que los enfermeros priorizan la ética profesional y les preocupa la seguridad del paciente, también implica que esta preocupación puede no influir consistentemente en sus actitudes y comportamientos. Para explorar aún más la relación entre la sensibilidad moral y la cultura de seguridad del paciente de los enfermeros, deben realizarse estudios futuros que incluyan enfermeros de diversos

orígenes culturales y ámbitos sanitarios, utilizando métodos cualitativos y cuantitativos.

Declaración de contribución de autoría CRediT

Conceptualización: Melike Durmaz, Saide Faydali
 Metodología: Melike Durmaz, Saide Faydali
 Curación de los datos: Melike Durmaz
 Análisis formal: Saide Faydali
 Redacción del borrador original: Melike Durmaz, Saide Faydali
 Redacción-revisión: Melike Durmaz, Saide Faydali
 Edición: Melike Durmaz, Saide Faydali
 Todos los autores han acordado la versión final

Responsabilidades éticas

Se obtuvo aprobación ética del Comité de ética no invasiva de la Universidad Selcuk, la Facultad de Enfermería y el hospital donde se realizó el estudio (Autorización del Hospital: Fecha: 27.12.2022, Número: E-30292447-100-429038; Autorización del Comité de ética).

Financiación

No existe financiación específica relacionada con esta investigación.

Declaración sobre el uso de la IA generativa y de las tecnologías asistidas por la IA en el proceso de redacción

Los autores no utilizaron IA en este estudio.

Conflicto de intereses

Los autores declaran la ausencia de conflicto de intereses.

Disponibilidad de los datos

Todos los datos están incluidos en el documento.

Bibliografía

- Boz I, Ince S. The effect of caring ethics course on study nurse student's ethical sensitivity level: Comparative study. *Türkiye Klinikleri J Med Ethics*. 2019;27:40–7, <http://dx.doi.org/10.5336/mdethic.2018-62882>.
- Oral T, Bekman FB. Investigation of occupational disease factors exposed by human health services employees in terms of OHS. *JGEHES*. 2021;3:160–78, <http://dx.doi.org/10.51123/jgehes.2021.27>.
- Ertug N, Aktas D, Faydali S, Yalcin O. Ethical sensitivity and related factors of nurses working in the hospital setting. *Acta Bioethica*. 2014;20:265–70.
- Dulgerler S, Durgu N, Guler C. Ethical sensitivity levels of employed and student nurses and effective factors. *Journal of Medical Ethics-Law and History*. 2020;28:345–53, <http://dx.doi.org/10.5336/mdethic.2020-73700>.
- Köktürk Dalcı B, Sendir M. determining the relationship between nurses personal values and their ethical sensitivity. *Florence Nightingale Journal of Nursing*. 2016;24:1–9.
- Milliken A, Grace P. Nurse ethical awareness: Understanding the nature of everyday practice. *Nursing Ethics*. 2017;24:517–24, <http://dx.doi.org/10.1177/0969733015615172>.
- Tosun H. Moral Sensitivity Questionnaire (MSQ): Turkish adaptation of the validity and reliability. *Journal of Contemp Med*. 2018;8:316–21, <http://dx.doi.org/10.16899/gopctd.467052>.
- Rizalar S, Büyük ET, Sahin R, As T, Uzunkaya G. Patient safety culture and influencing factors of nurses. *Dokuz Eylül University Faculty of Nursing electronic journal*. 2016;9:9–15.
- Erdagi S, Ozer N. Examining the working environments, patient safety culture perceptions and burnout status of nurses working in surgical clinics. *Journal of Nursology*. 2015;18:94–106, <http://dx.doi.org/10.17049/ahsbd.90265>.
- Karayurt O, Damar HT, Bilik O, Özdöker S, Duran M, Duran M. The evaluation of patient safety culture and use of the surgical safety checklist in the operating room. *Acibadem University Health Sciences Journal (AUHSJ)*. 2017;1:16–23.
- Tuncay A, Kılıc M. The effect of patient safety culture on the tendency to medical errors of nurses. *Journal of Health Administration*. 2023;26:557–74.
- Filizöz B, Mesci G, Asci A, Bağcıvan E. Nurses' ethical sensitivity: Research on Central Public Hospitals in Sivas Province. *Turkish Journal of Business Ethics*. 2015;8:56–66, <http://dx.doi.org/10.12711/TJBE.201581.0144>.
- Weaver K, Morse J, Mitcham C. Ethical sensitivity in professional practice: concept analysis. *Journal of Advanced Nursing*. 2008;62:607–18, <http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2008.04625.x>.
- Türkmen E, Altıntaş S, Baykal Ü, Seren S, Altıntaş S. Development of patient safety culture scale. *Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences*. 2011;14:38–46.
- Wang L, Lu H, Dong X, Huang X, Li B, Wan Q, Shang S. The effect of nurse staffing on patient-safety outcomes: A cross-sectional survey. *Journal of Nursing Management*. 2020;28:1758–66, <http://dx.doi.org/10.1111/jonm.13138>.
- Alpar R. Applied statistics and validity-reliability with examples from sports, health and educational sciences. 4th ed. Ankara: Detay publisher; 2016. p. 181–207.
- Tabachnick BG, Fidell LS. *Using Multivariate Statistics* (sixth ed.) Pearson. Boston. 2013:67–73.
- Schober P, Boer C, Schwarte LA. Correlation coefficients: Appropriate use and interpretation. *Anesthesia and Analgesia*. 2018;126:1763–8, <http://dx.doi.org/10.1213/ANE.0000000000002864>.
- Boga SM, Sayilan AA, Baydemir C. Perception of care quality and ethical sensitivity in surgical nurses. *NursEthics*. 2020;27:673–85, <http://dx.doi.org/10.1177/0969733020901830>.
- Borhani F, Abbaszadeh A, Mohammadi E, Ghasemi E, Hoseinabad-Farahani MJ. Moral sensitivity and moral distress in Iranian critical care nurses. *Nurs Ethics*. 2017;24:474–82, <http://dx.doi.org/10.1177/0969733015604700>.
- Kaya E, Özdelikara A. The Effect of moral sensitivity levels of intensive care nurses on their attitudes towards death: A descriptive study. *Türkiye Klinikleri J Nurs Sci*. 2022;14:1166–73, <http://dx.doi.org/10.5336/nurses.2022-90963>.
- Alabbas AM, Althubayni AS, Alfaki M, Alharthi FA, AlKarani A. Evaluation of patientsafety culture as perceived by nurses during the COVID-19 pandemic. *Frontiers of Nursing*. 2023;10:125–34, <http://dx.doi.org/10.2478/fon-2023-0013>.
- Yildirim GO, Sari D, Erdem Onder H, Aktan GG. Investigation of ethical sensitivity of operating room nurses. *Izmir Katip Celebi University Faculty of Health Sciences Journal*. 2023;8:373–9.

24. You D, Maeda Y, Bebeau MJ. Gender differences in moral sensitivity: A meta-analysis. *Ethics & Behavior*. 2011;21:263–82, <http://dx.doi.org/10.1080/10508422.2011.585591>.
25. Ye B, Luo E, Zhang J, Chen X, Zhang J. Moral sensitivity and emotional intelligence in intensive care unit nurses. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2022;19:5132, <http://dx.doi.org/10.3390/ijerph19095132>.
26. Choe K, Kim S, Lee C, Kim S. Effect of ethics seminar on moral sensitivity and ethical behavior of clinical nurses. *Int J Environ Res Public Health*. 2020;31:241, <http://dx.doi.org/10.3390/ijerph18010241>.
27. Tas Arslan F, Calbbinici P. Moral sensitivity, ethical experiences and related factors of pediatric nurses: A cross-sectional, correlational study. *Acta Bioethica*. 2018;24:9–18, <http://dx.doi.org/10.4067/S1726-569X2018000100009>.
28. Iseri O, Saritas H. Investigation of the professional values and patient safety attitudes of nurses working in surgery and internal clinics. *J Health Sci*. 2023;32:56–64, <http://dx.doi.org/10.34108/eujhs.998060>.
29. Bacaksız FE, Taskiran G, Uğuz G, Seren AKH. Evaluation of national studies, which had been published in the last decade (2008-2017) related to ‘‘patient safety’’ in Turkey: A bibliographic review. *J Acad Res Nurs*. 2020;6:523–37, <http://dx.doi.org/10.5222/jaren.2020.63625>.
30. Karaca A, Akin, Seren Harmanci AK. The relationship between perceived quality of care and the patient safety culture of Turkish nurses. *Journal of Nursing Research*. 2022;30:e223.
31. Ozturk Z, Ekinci N, Ozzeybek Tas M. Determining physicians and nurses’ perceptions of patient safety culture: A sample hospital in Ankara. *Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences*. 2022;24:1433–45.
32. Dogrusöz LA, Polat S, Kumsar AK. Patient safety culture for nurses: A sectional study at a university hospital. *International Journal of Society Researches*. 2020;16:1374–95, <http://dx.doi.org/10.26466/opus.687171>.
33. Solak M, Topcu S. Evaluation of nurses’ patient safety culture. *Izmir Democracy University Health Sciences Journal*. 2022;5:681–93, <http://dx.doi.org/10.52538/duhes.1140221>.
34. Ertürk C, Dönmez P, Ozmen D. Evaluation of patient safety culture of nurses working in hospitals in Manisa city center. *Journal of Ege University Nursing Faculty*. 2016;32:19–33.
35. Ozdemir FK, Sahin ZA. Perceptions of nurses regarding the patient safety culture: The Kars case. *ODU Journal of Medicine*. 2015;2:139–44.
36. Dilmen B, Talas MS. Evaluation of patient safety culture perceptions of nurses working in university hospitals in Turkey. *Turkish Journal of Health Science and Life*. 2022;5:255–71, <http://dx.doi.org/10.56150/tjhsl.1208654>.
37. Soltani Y, Moosazadeh Z, Alipour A, Esmaeili S. Effective interventions for improvement of moral sensitivity among nurses: A systematic review. *Journal of Nursing Reports In Clinical Practice*. 2023;1:30–7, 0000-0001-6889-8513.
38. Jasemi M, Goli R, Zabihi RE, Khalkhali H. Educating ethics codes by lecture or role-play; which one improves nursing students’ ethical sensitivity and ethical performance more? A quasi-experimental study. *Journal of Professional Nursing*. 2022;40:122–9, <http://dx.doi.org/10.1016/j.profnurs.2021.11.002>.
39. Tanaka M, Tezuka S. A scoping review of alternative methods of delivering ethics education in nursing. *Nurs Open*. 2022;9:2572–85, <http://dx.doi.org/10.1002/nop2.987>.
40. Warshawsky NE, Lake SW, Brandford A. Nurse managers describe their practice environments. *J Nurs Adm*. 2017;47:27–35, <http://dx.doi.org/10.1097/NAQ.0b013e3182a2f9c3>.
41. Thorp J, Baqai W, Witters D, Harter J, Agrawal S, Kanitkar K, et al. Workplace engagement and workers’ compensation claims as predictors for patient safety culture. *J Patient Saf*. 2012;8:194–201, <http://dx.doi.org/10.1097/PTS.0b013e3182699942>.